

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5091222-52.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: MARIA DA PENHA MELO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

MEDIDA DE URGÊNCIA. SAÚDE. CONSULTA ONCOLÓGICA - 1ª VEZ. ULTRAPASSADO O PRAZO DE 60 DIAS PREVISTO NA LEI 12.732/12. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. RECURDO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para que os réus, dentro de suas esferas de competência, AGENDEM PARA A PARTE AUTORA A CONSULTA AMBULATORIO 1ª VEZ - ONCOLOGIA NO PRAZO DE 10 DIAS, confirmando a provimento antecipatório anteriormente concedido. Publique-se. Intime-se. Após certificado o transito em julgado, dê-se baixa ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2024.

5091222-52.2024.4.02.5101

510015009014 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5091222-52.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: MARIA DA PENHA MELO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta pela parte autora em face da decisão do juízo que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

*"**Maria da Penha Melo de Oliveira**, devidamente qualificada na inicial, juíza a presente ação, com pedido de antecipação de tutela, em face da **União Federal, Estado do Rio de Janeiro e Município do Rio de Janeiro**, objetivando que os réus sejam condenadas a providenciarem, de forma imediata, **CONSULTA EM ONCOLOGIA**, nos termos da inicial.*

DECIDO.

Analisando o acervo documental, depreende-se que a autora tem indicação para realização do referido tratamento, conforme documentos médicos acostados aos autos (Evento 1 Anexo 2 Fls. 08/21 e Parecer do NAT de Evento 7).

Em que pesem tais circunstâncias, de todo inegáveis, fato é que a parte autora já foi inscrita no SER para realização de Consulta - Ambulatório 1ª vez - Neoplasias da Tireoide (Oncologia), conforme informações fornecidas pelo NAT em seu Parecer, estando em situação de espera em fila, ocupando a posição de nº 160.

Destarte, em havendo outros pacientes em igual ou mais crítica situação clínica do que a do autor, nesta mesma fila de espera e em posição anterior àquela que o mesmo ocupa, não se afigura isonômico que, em virtude de ordem judicial, o autor seja submetido de pronto à cirurgia de que necessita, a despeito dos outros pacientes, que, tanto quanto ele, são titulares do direito constitucional da assistência à saúde, fornecida pelo Estado.

Sobre o tema, o TRF2, já teve oportunidade de se manifestar, conforme se infere da ementa abaixo transcrita:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. TRATAMENTO MÉDICO. CIRURGIA. INTO. RESPEITO À FILA ADMINISTRATIVAMENTE ORGANIZADA. 1. O direito à saúde implica para o Poder Público o dever inescusável de adotar providências necessárias e indispensáveis para a sua promoção, estabelecidas de forma universal e igualitária. Nesse contexto jurídico, se o Poder Público negligencia no atendimento de seu dever, cumpre ao Poder Judiciário intervir, num verdadeiro controle judicial de política pública, para conferir efetividade ao correspondente preceito constitucional. 2. Todavia, o acesso ao referido direito deve ser compatibilizado com o princípio da isonomia, de forma a não garantir privilégios àqueles que procuram o Judiciário em detrimento dos que aguardam por tratamentos e cirurgias de acordo com a fila administrativamente estabelecida. Assim, não cabe ao Judiciário administrar hospitais, estabelecendo prioridades de natureza médica. Precedentes. 3. Dessa forma, cabe à Administração Pública, mediante exame com base em critérios técnicos, aferir a possibilidade de internação no INTO ou em qualquer outro hospital da rede pública, respeitando a fila administrativamente estabelecida. 4. É inviável, em um quadro insatisfatório, socializar o custeio de internação em rede hospitalar privada. Do mais, o deferimento do pedido, nesta hipótese, também representaria verdadeira preterição aos pacientes que aguardam na fila de espera. Precedentes. 5. Apelação conhecida e desprovida.

(TRF2, Sétima Turma, AP 0113602-43.2013.4.02.5101, Rel. Des. Fed. JOSÉ ANTONIO NEIVA, DJe 27/10/2016)

Isto posto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada."

Em seu recurso, a parte autora reitera que foi diagnosticada com neoplasia da tireoide, com resultado em 24/07/2024, e ainda está aguardando em fila, sem previsão, para a primeira consulta em oncologia.

Decisão do evento 3, deferindo a liminar.

Nos autos do processo originário há informação de que foi agendada consulta ambulatorial de 1ª vez - Neoplasias da Tireoide (Oncologia) para Hospital do Câncer I - INCA I em 02/12/2024 às 08h00min.

VOTO

Tendo em vista que não houve alteração do quadro fático, mantenho o já decidido no evento 3, cuja fundamentação passa a fazer parte integrante do presente voto. Vejamos:

A parte autora, idosa de 69 anos, alega ter sido diagnosticada com neoplasias da tireoide (Oncologia) conforme exame com resultado em 24/07/2024, sendo encaminhada para CONSULTA EM ONCOLOGIA - Ambulatório 1ª vez - Neoplasias da Tireoide (Oncologia), em 23/09/2024 e inserida no Sistema Estadual de Regulação - SER.

Juntou aos autos exame de citologia, com conclusão de suspeita para neoplasia folicular, datado de 24/07/2024 (Evento 1, ANEXO2, pág. 10).

EXAME DE CITOLOGIA

MATERIAL: PAAF de nódulo tireoidiano no terço inferior do lobo esquerdo, PAAF de nódulo tireoidiano no istmo.

MACROSCOPIA:

A) PAAF de nódulo tireoidiano no terço inferior do lobo esquerdo:
Recebemos frasco contendo 3 lâminas com esfregaços já confeccionados, e os coramos pelo método de Papanicolaou.

B) PAAF de nódulo tireoidiano no istmo:
Recebemos frasco contendo 3 lâminas com esfregaços já confeccionados, e os coramos pelo método de Papanicolaou.

MICROSCOPIA:

A)
Hemorrágicos.
Frequentes células foliculares.

B)
Hemorrágicos.
Frequentes células foliculares.

CONCLUSÃO MICROSCÓPICA:

A)
- Categoria IV de Bethesda: suspeito para Neoplasia folicular.

B)
- Categoria IV de Bethesda: suspeito para Neoplasia folicular.

- Obs.: O diagnóstico definitivo apenas por exame histopatológico.


Arivaldo Rocha Filho

Anexa também documento que comprova o **encaminhamento** para consulta em oncologia -1ª vez, realizado no dia 23/09/2024. Nele há a informação de que já houve a realização de biópsia de tireoide, realizado em 16/07/2024 (Evento 1, ANEXO2, pág. 19).

Encaminhamento de Usuários				
(Referência e Contra-referência)				
No de				
Méria Da Penha Melo De Oliveira				
De e Nascimento	Idade	Sexo	CPF	Nº do Cartão SUS
01.04.1955	69	Feminino	60884215768	706201036629564
No de Mãe				
ALYDE SILVA DE MELO				
Enereço	Bairro		CEP	
ESTRADA Curipós, 746, VILA O CASA 3 FUNDOS	Anil		227-3-330	
Município/Estado Residência	Município/Estado de Nascimento		Telefone Residencial	Telefone Celular
3304557 RIO DE JANEIRO/RJ	3304557 RIO DE JANEIRO/RJ		21975708049	975708049
Unidade de Saúde Solicitante	CNES	Telefone da Unidade		
SA S CF BARBARA MOSLE DE SOUZA AP 40	7382810	2042-3860		
Dados do Encaminhamento				
Especialidade encaminhada	Nome do Profissional (sugerido)		Unidade (sugerida)	
CONSULTA EM ENDOCRINOLOGIA - ONCOLOGIA				
Dados de Atendimento				
Peso (kg)	Altura (m)	Pressão (mm Hg)	Temperatura	
Motivo do Encaminhamento (e dados clínicos)				
20.06/2024 ultrassom tireoidiano: lobo direito nódulo sólido, mais largo do que alto, regular, homogêneo, hipoeoico, ao tecido, medindo 1,1x0,5x0,4 cm em seu terço médio tirado 4 lobo esquerdo nódulo sólido, mais largo do que alto, regular, homogêneo, hipoeoico, medindo 4,1x2,1x3,2 cm terço superior/istmo tirado 4				
Exames Solicitados e resultados				
25.08/2024 Ish 2,13 16/07/24 PAAF BETHESDA 4 nos dois nódulos. grata IMC 37 / ASA II BIÓPSIA DE TIREOIDE COM SUSPEIÇÃO DE NEOPLASIA DE FOLICULAR				
CIE 10	Data do Encaminhamento			
D410	23/09/2024			
Dr(a) MAGDA CAMILO DE SOUZA Médica CRM 605130				
* Ler e ver à consulta agendada a) documento de identificação; b) este formulário de Encaminhamento (Referência e Contra-referência); c) comprovante de agendamento do SISREG.				
* Se solicite ao médico da consulta especializada o preenchimento dos campos abaixo (contra-referência) para devolver ao médico do seu CMS ou Clínica de Família				
Contra-Referência (Para uso na Unidade Referenciada)				
No de do(a) paciente	Nº do Cartão SUS		Nº Prontuário	
Méria Da Penha Melo De Oliveira	706201036629564		4041310244502	
Unidade de Saúde de Origem	Endereço		Bairro	
SA S CF BARBARA MOSLE DE SOUZA AP 40	ESTRADA Curipós, 746, VILA O CASA 3		Anil	
Paciente inicial				
Exames solicitados e resultados				
Tratamentos indicados				

O NAT, em parecer, informa que a parte autora apresenta nódulos em tireoide, categoria IV de Bethesda, suspeitos para neoplasia folicular e que a Consulta/ Ambulatório 1ª Vez Neoplasias da Tireoide (Oncologia) e tratamento oncológico estão indicados ao manejo da condição clínica da Autora. Informa ainda que a parte autora foi inserida no SER no dia 23/09/2024, com situação "em fila", ocupando a 160ª posição.

A Lei nº 12.732, de 22.11.2012, que dispõe sobre o primeiro tratamento do paciente com neoplasia maligna comprovada no âmbito do SUS, assim estabelece:

"Art. 2º O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único."

§ 1º Para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput, considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com o início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso."

Da mesma forma, a Portaria nº 876/13 do Ministério da Saúde, que regula a aplicação da Lei nº 12.732/12, prevê que:

"Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre a aplicação da Lei nº 12.732, de 22 de novembro de 2012, que versa a respeito do primeiro tratamento do paciente com neoplasia maligna comprovada, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)."

"Art. 2º Para fins desta Portaria, considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna comprovada com:

I - a realização de terapia cirúrgica;

II - o início de radioterapia; ou

III - o início de quimioterapia."

Parágrafo único. Os pacientes sem indicação das terapêuticas antitumorais descritas nos incisos I a III do "caput" terão acesso a cuidados paliativos, incluindo-se entre estes o controle da dor crônica, conforme protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde."

"Art. 3º O prazo de 60 (sessenta) dias fixado no art. 2º da Lei nº 12.732, de 2012, para fins do primeiro tratamento cirúrgico ou quimioterápico ou radioterápico do paciente no SUS, contar-se-á a partir do registro do diagnóstico no prontuário do paciente."

§ 1º O prazo previsto no "caput" poderá ser reduzido por profissional médico responsável, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único."

§ 2º Não se aplica o prazo previsto no "caput" aos seguintes casos de neoplasia maligna:

I - câncer não melanótico de pele dos tipos basocelular e espinocelular;

II - câncer de tireoide sem fatores clínicos pré-operatórios prognósticos de alto risco; e

III - casos sem indicação de tratamento descritos no art. 2º."

A legislação fala em 60 dias da confirmação do diagnóstico para início do tratamento, que compreende em realização de cirurgia ou início de radioterapia ou quimioterapia.

No entanto, isso não ocorrerá até que a parte autora passe pela 1º consulta no ambulatório de oncologia, afim de que seja avaliado o tratamento necessário.

No entanto, **apesar de estar regulada desde 23/09/2024**, a Autora ainda está aguardando em fila, **na 160ª posição**. Ressalta-se ainda que o exame que comprova suspeita de **neoplasia é datado de 07/2024**, restando já **ultrapassado o prazo de 60 dias previsto na Lei**. Entendo que mesmo não existindo diagnóstico definitivo, a parte autora já realizou biópsia e já foi encaminhada ao serviço de oncologia. Destaco que não haja uma resposta final, ante ao resultado sugestivo, o encaminhamento efetuado pela administração não foi a realização de outro exame, mas sim a realização de consulta, sendo uma doença com progressão por vezes rápida, já ultrapassado o prazo de 60 dias, entendo que a consulta deve ser marcada.

Tendo em vista que a parte autora ainda se encontra numa posição muito longínqua e a demora no início do tratamento poderá impactar no resultado do tratamento, de modo que entendo presentes o *fumus boni iuris* e o *periculum in mora*.

Ressalta-se que nos autos do processo originário há informação de que foi agendada consulta ambulatorial de 1ª vez - Neoplasias da Tireoide (Oncologia) para Hospital do Câncer I - INCA I em 02/12/2024 às 08h00min, após ter sido deferida a tutela de urgência, a qual deve ser mantida.

ISTO POSTO, voto no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para que os réus, dentro de suas esferas de competência, AGENDEM PARA A PARTE AUTORA A CONSULTA AMBULATÓRIO 1ª VEZ - ONCOLOGIA NO PRAZO DE 10 DIAS, confirmando a provimento antecipatório anteriormente concedido. Publique-se. Intime-se. Após certificado o transito em julgado, dê-se baixa ao Juizado de origem.